

REPETITOIRES MEDECINE INTERNE

Prof Gérard WAEBER
Département de Médecine
CHUV, Lausanne



UNIL | Université de Lausanne

Faculté de biologie
et de médecine

Blueprint (approximatif)

- 65 % : thèmes hospitaliers
- 35 % : thèmes ambulatoires

Plus spécifiquement

- 40 % situations aiguës
- 25 % situations chroniques
- 7 % réhabilitation
- 7 % palliatifs
- 15 % urgences
- 7 % préventifs

Un malade âgé de 60 ans se rend aux urgences en raison de l'apparition subite il y a deux jours de douleurs lancinantes touchant la région orbitaire gauche et le front à gauche. Ces douleurs s'accompagnent d'un état de fatigue, de malaises et, depuis la veille, d'un placard érythémateux au niveau des régions temporale et frontale gauches. L'anamnèse familiale est sans particularité, exception faite d'une visite, il y a deux semaines, chez une nièce de 7 ans atteinte d'une maladie infantile.

L'examen clinique montre un placard érythémateux avec des vésicules à liquide clair groupées en bouquets et quelques croûtes sur le front et la paupière à gauche s'arrêtant à la ligne médiane. Le malade doit cligner de l'oeil de façon répétée, et son oeil gauche est rouge et larmoyant. Sa température est de 38 °C.

Quel examen est nécessaire afin de mettre en place un traitement approprié?



(A) une formule sanguine complète, des paramètres inflammatoires et des sérologies virales



(B) une ponction lombaire



(C) une biopsie cutanée



(D) un status ophtalmologique avec évaluation avec la lampe à fente



(E) un CT cérébral

Un malade âgé de 60 ans se rend aux urgences en raison de l'apparition subite il y a deux jours de douleurs lancinantes touchant la région orbitaire gauche et le front à gauche. Ces douleurs s'accompagnent d'un état de fatigue, de malaises et, depuis la veille, d'un placard érythémateux au niveau des régions temporale et frontale gauches. L'anamnèse familiale est sans particularité, exception faite d'une visite, il y a deux semaines, chez une nièce de 7 ans atteinte d'une maladie infantile.

L'examen clinique montre un placard érythémateux avec des vésicules à liquide clair groupées en bouquets et quelques croûtes sur le front et la paupière à gauche s'arrêtant à la ligne médiane. Le malade doit cligner de l'oeil de façon répétée, et son oeil gauche est rouge et larmoyant. Sa température est de 38 °C.

Quel examen est nécessaire afin de mettre en place un traitement approprié?

- ☒ (A) une formule sanguine complète, des paramètres inflammatoires et des sérologies virales
- ☐ (B) une ponction lombaire
- ☐ (C) une biopsie cutanée
- ☒ (D) un status ophtalmologique avec évaluation avec la lampe à fente
- ☐ (E) un CT cérébral



Patiente de 78 ans admise aux urgences pour la survenue depuis 48 heures d'une somnolence marquée, de troubles de la concentration et d'une fatigue intense. L'anamnèse révèle une opération pour un cancer du sein il y a 18 mois. L'examen clinique dévoile une tension artérielle de 110/70 mm Hg, une fréquence cardiaque à 72/min et une température à 36,5°C. Somnolente, mais réveillable, la patiente exécute les ordres simples. Elle est afebrile et l'examen neurologique dévoile l'absence d'asymétrie sensitivomotrice aux 4 membres. Les réflexes ostéotendineux sont faibles, mais symétriques. Babinski en flexion. Quel(s) examen(s) vous semble(nt) approprié(s) à ce stade?

-  1. EEG
-  2. Mesure de la calcémie et protéines sériques
-  3. IRM cérébrale
-  4. Mesure du taux d'ammonium

Patiente de 78 ans admise aux urgences pour la survenue depuis 48 heures d'une somnolence marquée, de troubles de la concentration et d'une fatigue intense. L'anamnèse révèle une opération pour un cancer du sein il y a 18 mois. L'examen clinique dévoile une tension artérielle de 110/70 mm Hg, une fréquence cardiaque à 72/min et une température à 36,5°C. Somnolente, mais réveillable, la patiente exécute les ordres simples. Elle est afebrile et l'examen neurologique dévoile l'absence d'asymétrie sensitivomotrice aux 4 membres. Les réflexes ostéotendineux sont faibles, mais symétriques. Babinski en flexion. Quel(s) examen(s) vous semble(nt) approprié(s) à ce stade?

1. EEG
2. **Mesure de la calcémie et protéines sériques**
3. IRM cérébrale
4. Mesure du taux d'ammonium

Patient de 72 ans connu pour une cardiopathie ischémique, rythmique (fibrillation auriculaire) et hypertensive. Il est hospitalisé pour une décompensation cardiaque globale avec anasarque. La tension artérielle est de 110/70 mm Hg avec une fréquence cardiaque à 98/min. Présence d'œdèmes importants des MI et d'une hypoventilation pulmonaire à la base gauche. La radiographie thoracique dévoile la présence d'un épanchement pleural couvrant le tiers inférieur du poumon gauche. L'approche thérapeutique à ce stade comprend (une ou plusieurs réponses possibles) ?

-  1. Ventilation non invasive (CPAP et oxygène)
-  2. Instauration d'un traitement de diurétiques de l'anse
-  3. Metoprolol
-  4. Ponction pleurale de l'épanchement
-  5. Amiodarone

Patient de 72 ans connu pour une cardiopathie ischémique, rythmique (fibrillation auriculaire) et hypertensive. Il est hospitalisé pour une décompensation cardiaque globale avec anasarque. La tension artérielle est de 110/70 mm Hg avec une fréquence cardiaque à 98/min. Présence d'œdèmes importants des MI et d'une hypoventilation pulmonaire à la base gauche. La radiographie thoracique dévoile la présence d'un épanchement pleural couvrant le tiers inférieur du poumon gauche. L'approche thérapeutique à ce stade comprend (une ou plusieurs réponses possibles) ?

-  1. Ventilation non invasive (CPAP et oxygène)
-  2. Instauration d'un traitement de diurétiques de l'anse
-  3. Metoprolol
-  4. Ponction pleurale de l'épanchement
-  5. Amiodarone

Ce patient de 65 ans est hospitalisé pour une hémorragie digestive sur rupture de varices œsophagiennes. Quarante-huit heures après un traitement par ligature des varices, vous constatez un taux d'hémoglobine à 72 g/l. Vous proposez de transfuser 2 culots érythrocytaires en urgence en attendant une nouvelle intervention de vos collègues gastroentérologues. En cours de transfusion, le patient développe une fièvre à 38,5°C et l'infirmière vous interpelle pour planifier la suite du traitement. Quelle(s) approche(s) vous semble(nt) adéquate(s) ?

- ☒ 1. Administrer de la ceftriaxone immédiatement
- ☒ 2. Administrer immédiatement un antihistaminique et de la prednisone i.v.
- ☒ 3. Arrêter la transfusion et vérifier l'identité et l'adéquation du culot érythrocytaire avec le patient
- ☒ 4. Administrer du paracétamol
- ☐ 5. Demander des hémocultures du receveur

Ce patient de 65 ans est hospitalisé pour une hémorragie digestive sur rupture de varices œsophagiennes. Quarante-huit heures après un traitement par ligature des varices, vous constatez un taux d'hémoglobine à 72 g/l. Vous proposez de transfuser 2 culots érythrocytaires en urgence en attendant une nouvelle intervention de vos collègues gastroentérologues. En cours de transfusion, le patient développe une fièvre à 38,5°C et l'infirmière vous interpelle pour planifier la suite du traitement. Quelle(s) approche(s) vous semble(nt) adéquate(s) ?

- ☒ 1. Administrer de la ceftriaxone immédiatement
- ☒ 2. Administrer immédiatement un antihistaminique et de la prednisone i.v.
- ☒ 3. Arrêter la transfusion et vérifier l'identité et l'adéquation du culot érythrocytaire avec le patient
- ☒ 4. Administrer du paracétamol
- ☐ 5. Demander des hémocultures du receveur

Cette patiente de 76 ans est hospitalisée pour une hémorragie digestive et une insuffisance cardiaque. Deux culots érythrocytaires sont prescrits en raison d'une hémoglobine à 62 g/l à son admission aux urgences. Durant la perfusion du second culot érythrocytaire, le patient développe une dyspnée aiguë sans fièvre. L'infirmière vous appelle en urgence. Vous évoquez le(s) diagnostic(s) suivant(s) ?

☒ 1. Embolie pulmonaire

☐ 2. Réaction transfusionnelle hémolytique

☐ 3. Réaction allergique

☐ 4. Œdème aigu pulmonaire

☐ 5. Sepsis.

Cette patiente de 76 ans est hospitalisée pour une hémorragie digestive et une insuffisance cardiaque. Deux culots érythrocytaires sont prescrits en raison d'une hémoglobine à 62 g/l à son admission aux urgences. Durant la perfusion du second culot érythrocytaire, le patient développe une dyspnée aiguë sans fièvre. L'infirmière vous appelle en urgence. Vous évoquez le(s) diagnostic(s) suivant(s) ?

☒ 1. Embolie pulmonaire

☐ 2. Réaction transfusionnelle hémolytique

☐ 3. Réaction allergique

☒ 4. Œdème aigu pulmonaire

☐ 5. Sepsis.

Mr GI:71 ans

Hospitalisé pour pneumonie compliquée d'un choc septique transitoire. Tazobac + Noradrénaline sevrée après 2 jours

**AA: Transfert aux soins continus J+5.
Hémodynamiquement stable. Douleurs abdominales diffuses sans EF. Transit sp mais diarrhées 5-6 x/j**

**Status: Afébrile. TA 105/74 . FC 98/min irrégulier.
Discrète défense sans détente aux 4 quadrants.
Reste non contributif.**

Mr GI:71 ans

Que proposez-vous?

- ☐ 1. Culture selles, toxine + métronidazole
- ☐ 2. Changement d'antibiotique
- ☐ 3. ECG
- ☐ 4. ASP
- ☐ 5. Autre?

Mr GI:71 ans

Que proposez-vous?

- ☒ 1. Culture selles, toxine + métronidazole
- ☒ 2. Changement d'antibiotique
- ☒ 3. ECG
- ☒ 4. ASP
- ☐ 5. Autre? angioCT abdominal

Patient de 74 ans hospitalisé pour des expectorations purulentes et un état fébrile. L'examen clinique et la radiographie confirment le diagnostic de pneumonie basale droite et un traitement de ceftriaxone est instauré. Six jours après l'hospitalisation, l'état fébrile perdure et l'auscultation pulmonaire dévoile une hypoventilation de la base droite couvrant la moitié de la plage pulmonaire. La radiographie thoracique dévoile une opacité couvrant les $\frac{2}{3}$ du poumon droit avec une ligne de Damoiseau positive. A ce stade, le prochain examen/traitement à planifier est ?

-  1. Recherche des antigènes légionnelles et pneumocoques dans les urines
-  2. Ajout d'un traitement d'érythromycine à la ceftriaxone
-  3. Ponction pleurale à but diagnostique
-  4. CT scan thoracique
-  5. Bronchoscopie et lavage broncho-alvéolaire.

Patient de 74 ans hospitalisé pour des expectorations purulentes et un état fébrile. L'examen clinique et la radiographie confirment le diagnostic de pneumonie basale droite et un traitement de ceftriaxone est instauré. Six jours après l'hospitalisation, l'état fébrile perdure et l'auscultation pulmonaire dévoile une hypoventilation de la base droite couvrant la moitié de la plage pulmonaire. La radiographie thoracique dévoile une opacité couvrant les $\frac{2}{3}$ du poumon droit avec une ligne de Damoiseau positive. A ce stade, le prochain examen/traitement à planifier est ?

-  1. Recherche des antigènes légionnelles et pneumocoques dans les urines
-  2. Ajout d'un traitement d'érythromycine à la ceftriaxone
-  3. Ponction pleurale à but diagnostique
-  4. CT scan thoracique
-  5. Bronchoscopie et lavage broncho-alvéolaire.

Cet homme de 64 ans, tabagique et souffrant d'une dyslipidémie traitée vous consulte pour un bilan de santé annuel. L'anamnèse dévoile la survenue de douleurs rétrosternales apparaissant lors d'efforts significatifs au fitness. Ces douleurs disparaissent spontanément et durent quelques minutes. L'examen clinique ne dévoile rien de particulier et l'ECG de repos montre un rythme sinusal régulier sans aucune altération spécifique. L'étape suivante chez cet homme est ?

- ☒ 1. Coronarographie
- ☐ 2. Instauration d'un traitement d'Aspirine 100 mg
- ☐ 3. Instauration d'un traitement d'Aspirine 100 mg et planifier une ergométrie
- ☐ 4. Hospitaliser le patient en urgence
- ☐ 5. Prévoir un CT thoracique en urgence pour exclure une dissection aortique.

Cet homme de 64 ans, tabagique et souffrant d'une dyslipidémie traitée vous consulte pour un bilan de santé annuel. L'anamnèse dévoile la survenue de douleurs rétrosternales apparaissant lors d'efforts significatifs au fitness. Ces douleurs disparaissent spontanément et durent quelques minutes. L'examen clinique ne dévoile rien de particulier et l'ECG de repos montre un rythme sinusal régulier sans aucune altération spécifique. L'étape suivante chez cet homme est ?

- ☒ 1. Coronarographie
- ☐ 2. Instauration d'un traitement d'Aspirine 100 mg
- ☒ 3. Instauration d'un traitement d'Aspirine 100 mg et planifier une ergométrie
- ☐ 4. Hospitaliser le patient en urgence
- ☐ 5. Prévoir un CT thoracique en urgence pour exclure une dissection aortique.

Vous suivez à votre cabinet le Dr Pénible. Vous souhaitez le mettre sous un traitement d'IPP mais il argumente que les IPP ont ces effets secondaires si pris chroniquement. En quoi aurait-il raison?

- ☒ a. Pneumonie
- ☒ b. Colite à *Clostridium difficile*
- ☒ c. Fracture de la hanche
- ☒ d. Hypovitaminose B12
- ☐ e. Hypomagnésémie

Vous suivez à votre cabinet le Dr Pénible. Vous souhaitez le mettre sous un traitement d'IPP mais il argumente que les IPP ont ces effets secondaires si pris chroniquement. En quoi aurait-il raison?

- ☒ a. **Pneumonie**
- ☒ b. **Colite à Clostridium difficile**
- ☒ c. **Fracture de la hanche**
- ☒ d. **Hypovitaminose B12**
- ☐ e. **Hypomagnésémie**

Patiente de 58 ans avec 3 épisodes de MTEV (EP + TVP) idiopathiques ces dernières 4 ans. Aucun processus oncologique et une anticoagulation de durée indéterminée est requise. BMI 30, diabétique insulino-traitée et créatinine à 280 microm/l secondaire à néphropathie diabétique et hypertensive. Sous Sintron et INR labile 1.1 à 3.5 ambulatoirement. Attitude?

- ☒ 1. NOAC (Xarelto 15mgQD)
- ☒ 2. HBMP prophylactique
- ☒ 3. Marcoumar
- ☒ 4. Filtre cave
- ☐ 5. Autre idée?

Patiente de 58 ans avec 3 épisodes de MTEV (EP + TVP) idiopathiques ces dernières 4 ans. Aucun processus oncologique et une anticoagulation de durée indéterminée est requise. BMI 30, diabétique insulino-traitée et créatinine à 280 microm/l secondaire à néphropathie diabétique et hypertensive. Sous Sintron et INR labile 1.1 à 3.5 ambulatoirement. Attitude?

- ☒ 1. NOAC (Xarelto 15mgQD)
- ☒ 2. HBMP prophylactique
- ☒ 3. Marcoumar
- ☒ 4. Filtre cave
- ☐ 5. Autre idée?: auto monitoring et evt ajout d'une faible dose de vitamine K

Vos connaissances sur le métabolisme du fer?

Une hyperferritinémie (>1000) doit évoquer en premier lieu une hémochromatose?

Vrai Faux

La présence d'une mutation (HFE Cys282Tyr) est la cause la plus fréquente d'HF ?

Vrai Faux

Dépistage populationnel recommandé ?

Vrai Faux

Si hémochromatose évoquée, la biopsie hépatique est requise ?

Vrai Faux

La cirrhose est la manifestation clinique la plus fréquente en présence d'une hémochromatose ?

Vrai Faux

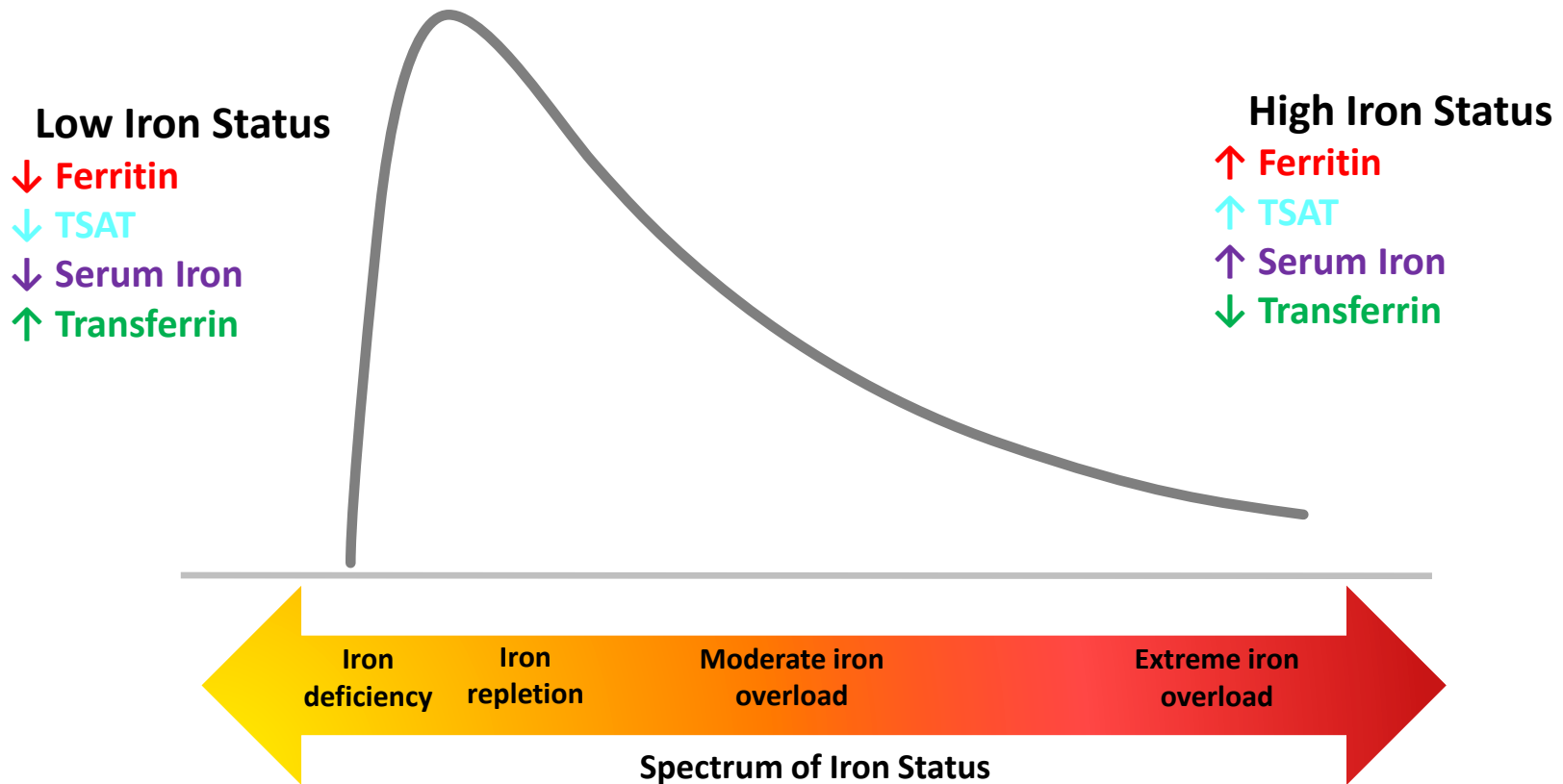
Biomarkers of Iron Status

Ferritin - iron *stores*

Transferrin Saturation (TSAT) - iron *absorption*

Serum Iron - iron in *blood*

Transferrin - iron *needs*



Conduite à tenir devant une hyperferritémie

- **homme: 300-400 $\mu\text{g/l}$**
- **femme: 200-300 $\mu\text{g/l}$**

Zone grise de normalité mais considérer des investigations si $> 300-500 \mu\text{g/l}$

Hyperferritémie

```
graph TD; A[Hyperferritémie] --> B[CST > 45%]; A --> C[CST < 45%]; B --> D["▪ hémochromatose<br/>▪ cytolysse hépatique<br/>▪ cytolysse musculaire<br/>▪ transfusions massives<br/>▪ dysérythropoïèse"]; C --> E["▪ inflammation<br/>▪ syndrome métabolique<br/>▪ alcoolisme<br/>▪ acéruoplasminémie"];
```

CST > 45%

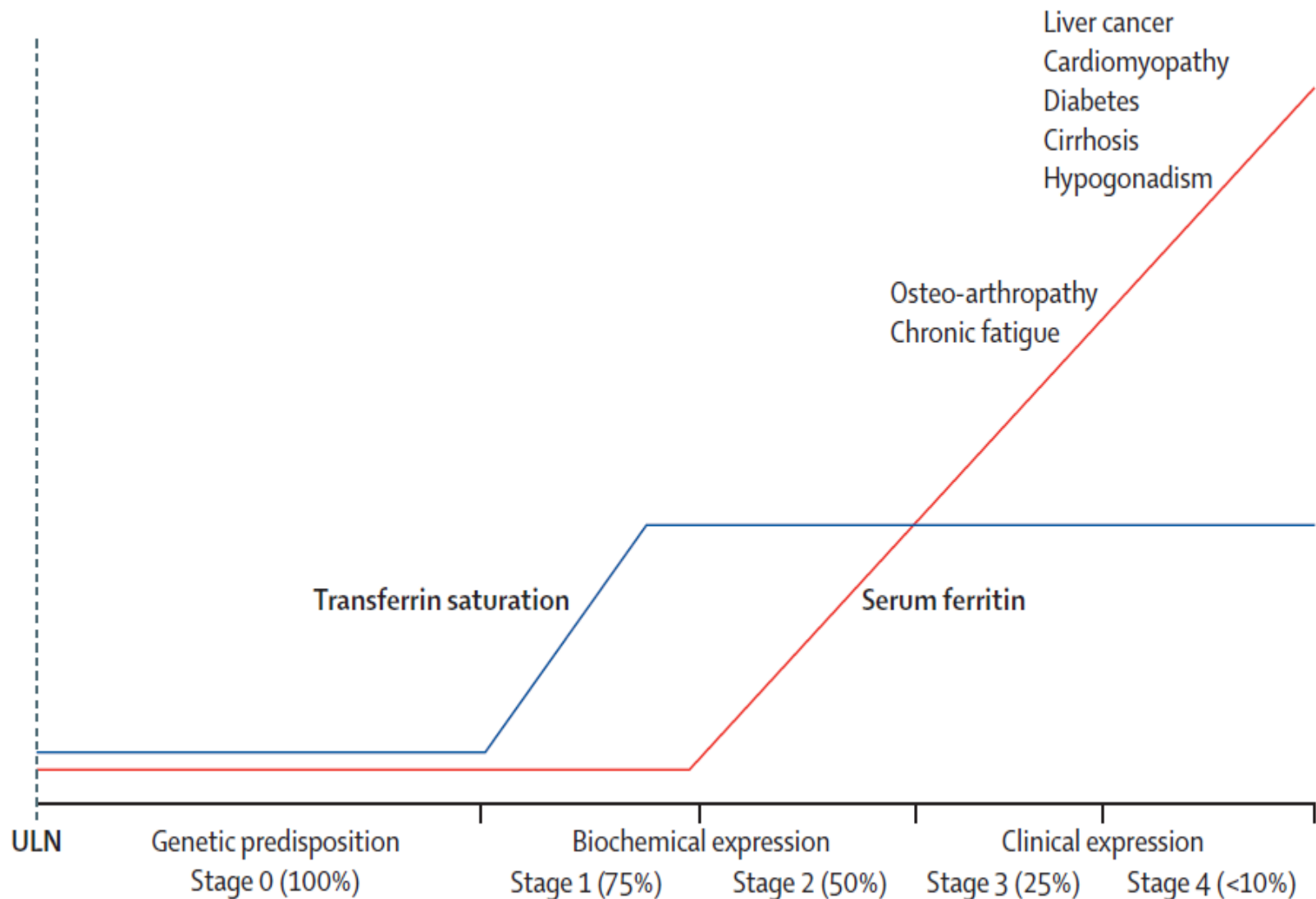
- hémochromatose
- cytolysse hépatique
- cytolysse musculaire
- transfusions massives
- dysérythropoïèse

CST < 45%

- inflammation
- syndrome métabolique
- alcoolisme
- acéruoplasminémie

Figure 2: Stages of haemochromatosis

Different stages of the haemochromatosis phenotype. Not all patients will develop the full disease. Only Cys282Tyr homozygosity can result in fully expressed disease (stage 4).⁸ ULN=upper limit of normal.



Clinical presentation, signs, and symptoms

☐ classiquement cirrhose + diabète + peau (evt dès ferritine > 1000) plus rare actuellement sauf si OH ou stéatose associés

☐ fatigue +++

☐ arthropathie (monoarthrite), chondrocalcinose

☐ ostéoporose (30%)

☐ cardiopathie

☐ hypogonadisme

Screening in the general population

The worldwide consensus is that general screening is not recommended for several reasons—ie, cost, the threat of discrimination (sometimes still with respect to insurances), and the substantial rate of false-positive or false-negative results when using transferrin saturation or serum ferritin concentration as screening tests.⁷⁸

Vos connaissances sur le métabolisme du fer?

Une hyperferritinémie (>1000) doit évoquer en premier lieu une hémochromatose?

Vrai

Faux

La présence d'une mutation (HFE Cys282Tyr) est la cause la plus fréquente d'HF ?

Vrai

Faux

Dépistage populationnel recommandé ?

Vrai

Faux

Si hémochromatose évoquée, la biopsie hépatique est requise ?

Vrai

Faux

La cirrhose est la manifestation clinique la plus fréquente en présence d'une hémochromatose ?

Vrai

Faux

Evaluation of New-Onset Ascites

F 60 ans

Mixed connective disease- HT pulmonaire

**Ascite nouvelle. Pas d'OH. Sous
diltiazem/furosemide**

Turgescence jugulaire

Ascite et splénomégalie à l'US

Ponction ascite effectuée

Test	Patient's Laboratory Values	Reference Range
Serum		
Aspartate aminotransferase, U/L	37	15-41
Alanine aminotransferase, U/L	9	14-54
Alkaline phosphatase, U/L	42	24-110
Total bilirubin, mg/dL	0.6	0.4-1.5
Albumin, g/dL	2.5 	3.5-4.8
White blood cell count, / μ L	4300	3200-9800
Hemoglobin, g/dL	9.6	12.0-15.5
Platelets, $\times 10^3$ / μ L	110 	150-450
International normalized ratio	1.1	0.9-1.1
Ascites		
Appearance	Yellow	
Albumin, g/dL	1 	
Protein, g/dL	3.5 	
Red blood cell count, $\times 10^6$ / μ L 	258	
White blood cells, /mm ³	145 	
% Neutrophils	2	
% Lymphocytes	55	

HOW DO YOU INTERPRET THESE TEST RESULTS?



A. Her ascites is primarily due to cirrhosis.



B. Her ascites is primarily due to chronically elevated pressures on the right side of the heart.



C. Her ascites is primarily due to abdominal malignancy.



D. Her ascites is primarily due to spontaneous bacterial peritonitis.

Ascite

85%	cirrhose
7%	néoplasique
3%	cardiaque

1/20: plus d'une étiologie à l'origine de l'ascite

Table 2. Typical Ascites Test Results Among the 3 Most Common Causes of Ascites

	SAAG (Threshold ≥ 1.1 g/dL) ^a	Ascites Protein (Threshold ≥ 2.5 g/dL) ^a
Cirrhosis	High	Low
Heart failure	High	High
Peritoneal malignancy	Low	High

Table 2. Typical Ascites Test Results Among the 3 Most Common Causes of Ascites

	SAAG (Threshold ≥ 1.1 g/dL) ^a	Ascites Protein (Threshold ≥ 2.5 g/dL) ^a
Cirrhosis	High	Low
Heart failure	High	High
Peritoneal malignancy	Low	High

Dans le cas présenté:

SAAG = 1.5

Prot = 3.5

What Are Alternative Diagnostic Testing Approaches?

Though diagnostic paracentesis is the standard first step for evaluating new-onset ascites, serum brain natriuretic peptide (BNP) of greater than 364 pg/mL has been demonstrated to diagnose heart failure-related ascites with 99.1% accuracy.⁷ Serum BNP may be useful if ascites results are inconclusive for diagnosis.

Patient Outcome

The patient managed her heart failure-related ascites successfully with sodium restriction, diuretics, and pulmonary hypertension therapies including treprostinil and sildenafil.

HOW DO YOU INTERPRET THESE TEST RESULTS?

A. Her ascites is primarily due to cirrhosis.

B. Her ascites is primarily due to chronically elevated pressures on the right side of the heart.

C. Her ascites is primarily due to abdominal malignancy.

D. Her ascites is primarily due to spontaneous bacterial peritonitis.

JAMA Diagnostic Test Interpretation

Evaluating Thrombocytopenia During Heparin Therapy

JAMA February 6, 2018 Volume 319, Number 5

H 45 ans

Ischémie mésentérique sur thrombose il y a 2 semaines ttt chirurgicalement et héparine de basPM. Trois semaines plus tard: nouvelle thrombose. Tazobac et reprise chirurgicale. Survenue d'un thrombose veine fémorale et EP

Table 1. Laboratory Evaluation During Hospitalization

Laboratory Test	At Admission	24 Hours Postadmission	36 Hours Postadmission	Reference Ranges
White blood cell count, $\times 10^3/\mu\text{L}$	18.7	17.9	14.2	4-11
Hemoglobin, g/dL	10.5	9.2	8.9	13.5-17.5
Hematocrit, %	31.5	27.6	28.5	40-54
Platelet count, $10^3/\mu\text{L}$	369	495	62	150-400
International normalized ratio	1.1		1.0	<1.1
Partial thromboplastin time, s	34		33	25-35
HIT antibody ELISA, optical density units ^a			2.163	<0.4

HOW WOULD YOU INTERPRET THESE TEST RESULTS?



A. Continue heparin for new thrombosis.



B. Replace heparin with argatroban for heparin-induced thrombocytopenia.



C. Replace piperacillin-tazobactam with meropenem for antibiotic-induced thrombocytopenia.



D. Transfuse platelets for risk of postoperative bleeding.

Table 2. Pretest Probability Assessment of HIT Using the 4Ts Score^a

	2 points	1 point	0 points
Thrombocytopenia	Platelet count decrease >50%; and platelet nadir $\geq 20 \times 10^3/\mu\text{L}$	Platelet count decrease 30%-50%; or platelet nadir $10\text{-}19 \times 10^3/\mu\text{L}$	Platelet count decrease <30%; or platelet nadir $<10 \times 10^3/\mu\text{L}$
Timing of platelet count decrease	Clear onset between 5-10 d; or platelet decrease <1 d (prior heparin exposure within 30 d)	Consistent with 5-10 d decrease, but not clear (eg, missing platelet counts); or onset after d 10; or decrease <1 d (heparin exposure 30-100 d prior)	Platelet count decrease <4 d without recent heparin exposure
Thrombosis or other sequelae	New thrombosis (confirmed); or skin necrosis at heparin injection sites; or acute systemic reaction after intravenous heparin bolus	Progressive or recurrent thrombosis; or nonnecrotizing skin lesions; or suspected thrombosis (not proven)	None
Other causes for thrombocytopenia	None apparent	Possible	Definite

Positif si > 3

HOW WOULD YOU INTERPRET THESE TEST RESULTS?

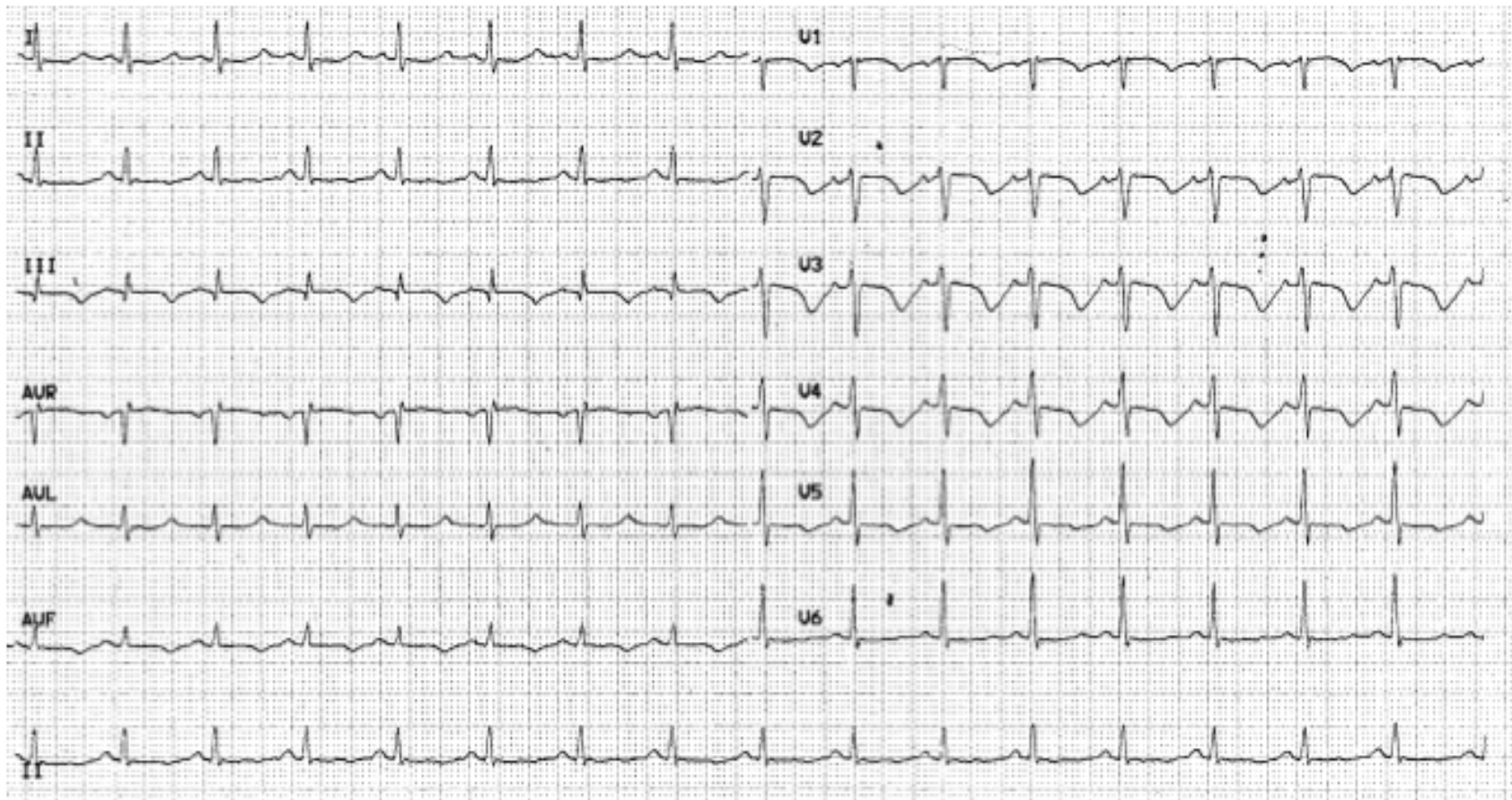
A. Continue heparin for new thrombosis.

B. Replace heparin with argatroban for heparin-induced thrombocytopenia.

C. Replace piperacillin-tazobactam with meropenem for antibiotic-induced thrombocytopenia.

D. Transfuse platelets for risk of postoperative bleeding.

Ce jeune homme toxicomane de 24 ans est admis aux urgences pour une alcoolisation aiguë, associée à une agitation importante et des vomissements. L'infirmière vous montre son ECG d'entrée. Vous proposez le(s) premier(s) soin(s) suivant(s) ?



 1. Prescription d'un antiémétique de type ondansétron

 2. Prescription d'halopéridol

 3. Prescription de méthadone

 4. Administration de magnésium intraveineux

 5. Prescription d'aspirine.

 1. Prescription d'un antiémétique de type ondansétron

 2. Prescription d'halopéridol

 3. Prescription de méthadone

 4. **Administration de magnésium intraveineux**

 5. Prescription d'aspirine.

Femme de 26 ans, stressée dans un contexte d'examens universitaires, se plaint de bouffées d'angoisse et de manière nouvelle, peine à trouver son souffle à l'effort (cours de danse). Aucun antécédent particulier ni allergie. Pas de médicament sauf une contraception orale. Examen clinique normal.

Etape suivante dans la démarche diagnostique ou thérapeutique:

-  1. Radiographie du thorax
-  2. Fonctions pulmonaires
-  3. Prescription d'anxiolytiques
-  4. D-dimères
-  5. Psychothérapie de soutien

Femme de 26 ans, stressée dans un contexte d'examens universitaires, se plaint de bouffées d'angoisse et de manière nouvelle, peine à trouver son souffle à l'effort (cours de danse). Aucun antécédent particulier ni allergie. Pas de médicament sauf une contraception orale. Examen clinique normal.

Etape suivante dans la démarche diagnostique ou thérapeutique:

-  1. Radiographie du thorax
-  2. Fonctions pulmonaires
-  3. Prescription d'anxiolytiques
-  4. D-dimères
-  5. Psychothérapie de soutien

Femme de 45 ans hospitalisée en urgence pour dyspnée aigüe dans le contexte de contraception orale et fumée sans fièvre ou expectorations. Saturation O₂ à 88% sous air ambiant. Gazométrie P_{O2} 84 mmHg, P_{CO2} 32 mmHg, pH 7.55

Etape suivante dans la démarche diagnostique

-  1. Radiographie du thorax
-  2. D-Dimères
-  3. Angio-CT thoracique
-  4. ECG
-  5. Echocardiogramme

Femme de 45 ans hospitalisée en urgence pour dyspnée aigüe dans le contexte de contraception orale et fumée sans fièvre ou expectorations. Saturation O₂ à 88% sous air ambiant. Gazométrie P_{O2} 84 mmHg, P_{CO2} 32 mmHg, pH 7.55

Etape suivante dans la démarche diagnostique

-  1. Radiographie du thorax
-  2. D-Dimères
-  3. Angio-CT thoracique
-  4. ECG
-  5. Echocardiogramme

Femme de 45 ans hospitalisée en urgence pour dyspnée subaigüe dans le contexte de contraception orale et fumée sans fièvre ou expectoration. Saturation O2 à 88% sous air ambiant. Gazométrie P02 84 mmHg, PCO2 32 mmHg, pH 7.55. **Découverte d'embolies pulmonaires multiples dont plusieurs centrales à cheval sur le TP.** La patiente souffre d'une dyspnée stade IV aux urgences, tensions artérielles à 88/45 mmHg et FC à 130/min

Etape suivante?

-  1. Héparine de bas poids moléculaire
-  2. Héparine non fractionnée iv
-  3. Aspirine iv et héparine non fractionnée
-  4. Héparine de bas poids moléculaire et sintron
-  5. thrombolyse

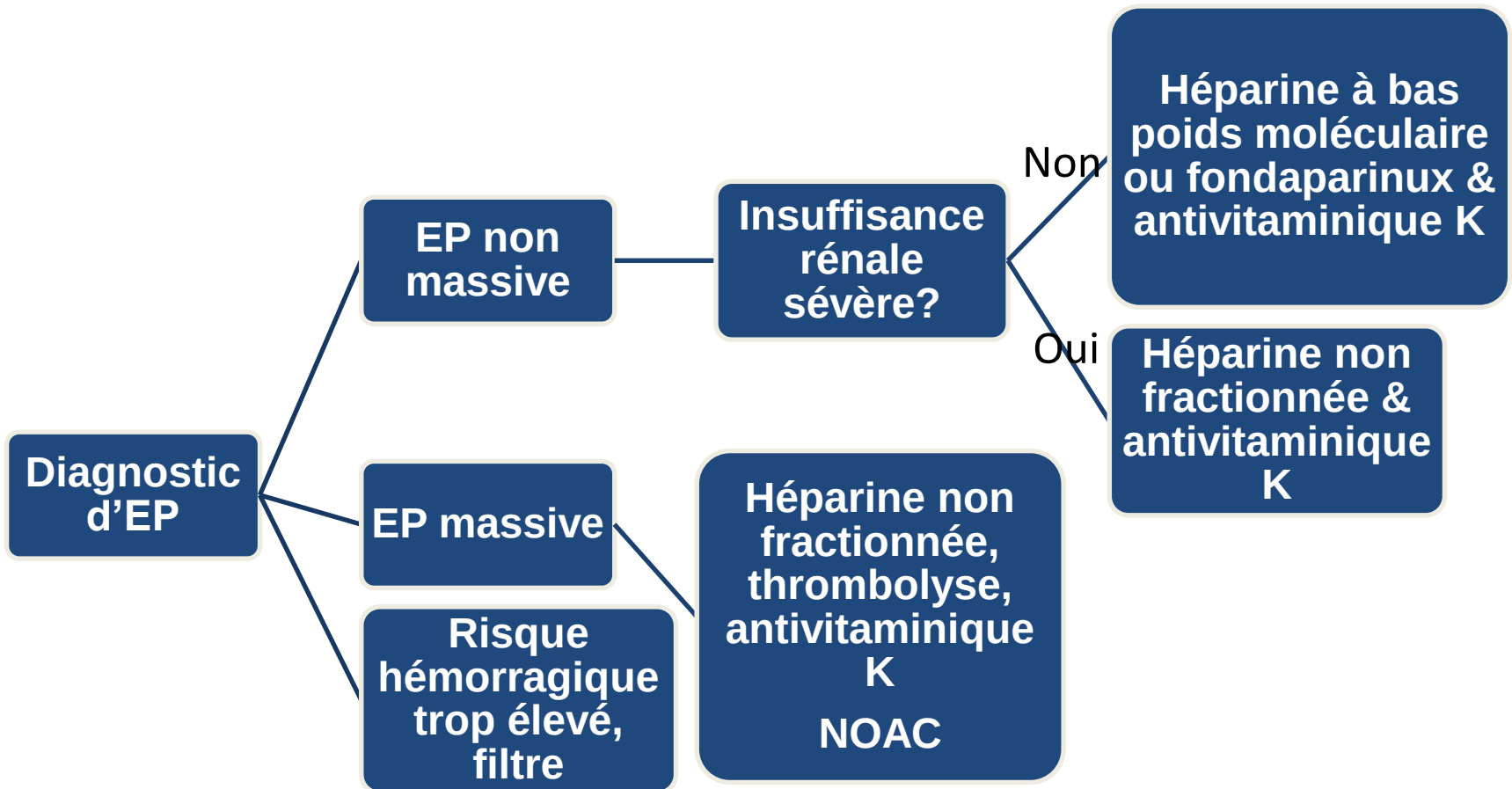
Femme de 45 ans hospitalisée en urgence pour dyspnée subaigüe dans le contexte de contraception orale et fumée sans fièvre ou expectoration. Saturation O2 à 88% sous air ambiant. Gazométrie P02 84 mmHg, PCO2 32 mmHg, pH 7.55. **Découverte d'embolies pulmonaires multiples dont plusieurs centrales à cheval sur le TP.** La patiente souffre d'une dyspnée stade IV aux urgences, tensions artérielles à 88/45 mmHg et FC à 130/min

Etape suivante?

- ☒ 1. Héparine de bas poids moléculaire
- ☒ 2. Héparine non fractionnée iv
- ☒ 3. Aspirine iv et héparine non fractionnée
- ☒ 4. Héparine de bas poids moléculaire et sintron
- ☐ 5. thrombolyse

Classification de la MTEV: important pour le pronostic du patient

- **TVP**
 - proximale (v. poplitée ou au-dessus) vs distale
 - *Attention: thrombophlébites des veines saphènes ≠ TVP!*
- **EP**
 - Massive (TA systolique < 90 mm Hg, allant jusqu'à l'arrêt cardiorespiratoire) vs non-massive
- **TVP/EP idiopathique** (sans facteur déclenchant) vs secondaire (par ex. pilule, post-opératoire)



Quelle anticoagulation?

1. Héparine?
2. Héparine de bas poids moléculaire?
3. Sintron, Marcoumar?
4. Anticoagulants oraux directs?

Quelle anticoagulation?

1. Héparine?

- . si embolie pulmonaire massive
- . Si insuffisance rénale
- . Si geste chirurgical rapide requis

Quelle anticoagulation?

1. Héparine?

2. Héparine de bas poids moléculaire?

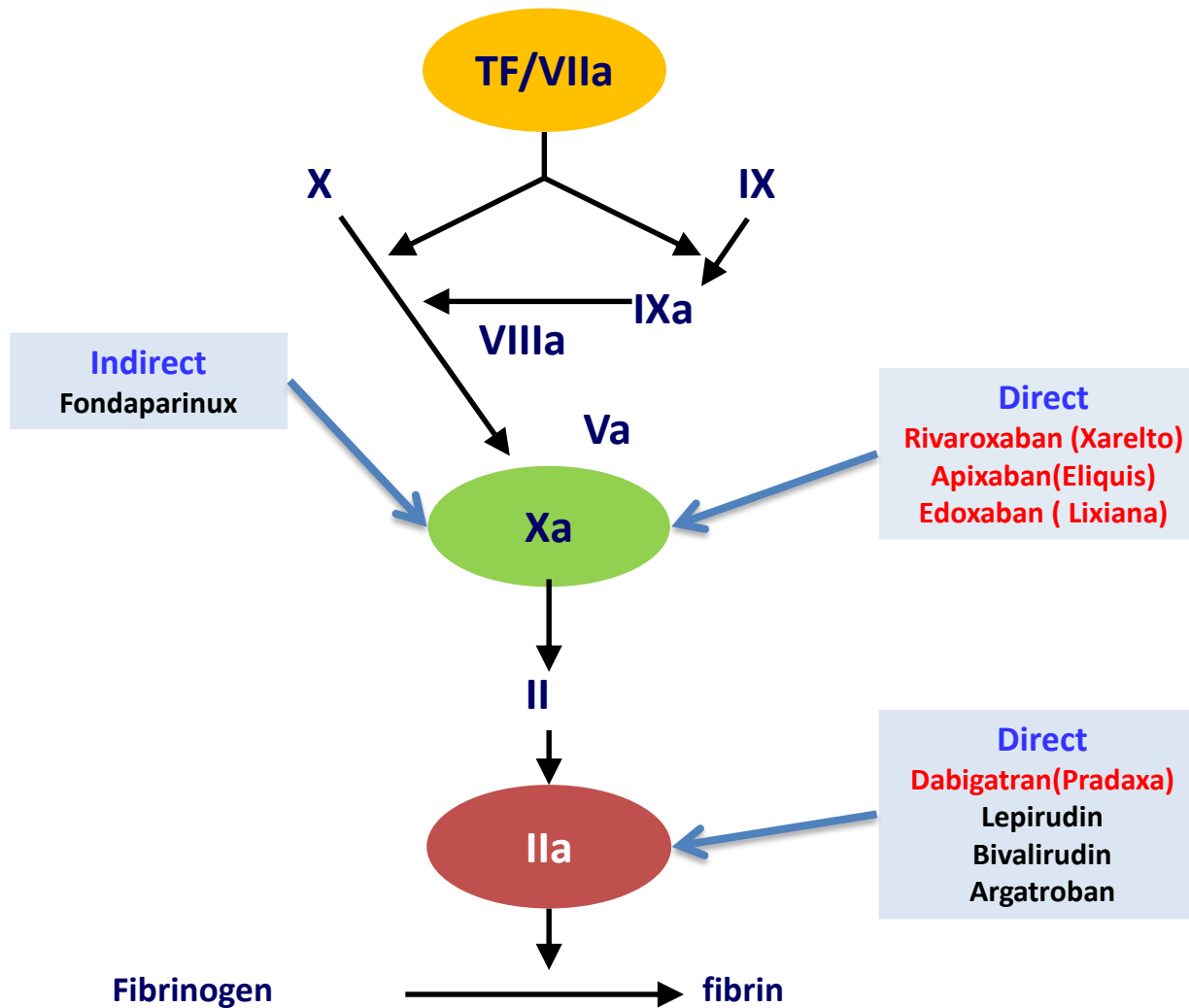
- . Pas de monitoring requis
- . Permet l'initiation du Sintron en parallèle
- . Caveat si insuffisance rénale

Quelle anticoagulation?

1. Héparine?
2. Héparine de bas poids moléculaire?
3. Sintron, Marcoumar?
 - . Monitoring INR
 - . Inertie à l'initiation
 - . Reverser la crase reste possible (Konakion, PFCs, Prothromplex...)

Quelle anticoagulation?

1. Héparine?
2. Héparine de bas poids moléculaire?
3. Sintron, Marcoumar?
4. Anticoagulants oraux directs?
 - . Pas de monitoring
 - . Anticoagulation plus stable
 - . Plus difficile à reverser
 - . prix



¹Wessler S. & Yan E.T., *Thrombo Diath Haemorrh* 32: 71-78, 1974; ²Mann K.G. et al., *J Thromb Haemost* 1:1504-1514, 2003

Anticoagulants parentéraux

Caractéristiques	Héparine non fractionnée	Héparines à bas poids moléculaire*	Fondaparinux
Mode d'action	Inhibition facteur IIa>Xa	Inhibition facteur Xa>IIa	Inhibition facteur Xa
Demi-vie	1 heure	4 heure	17 heures
Voie d'administration	i.v. en continue (s.c.)	s.c. 1-2 x jour sel. poids	s.c. 1x jour sel. poids
Surveillance de l'effet anticoagulant	PTT (cible: 2x le PTT de départ)	non	non
Antagonisable	protamine	(protamine)	non
Hémorragie majeure	1-2%	1-2%	1-2%
Risque de TIH (médecine interne)	0.1-1% (monitoring plaquettaire)	< 0.1%	-
Élimination rénale	non	oui	oui

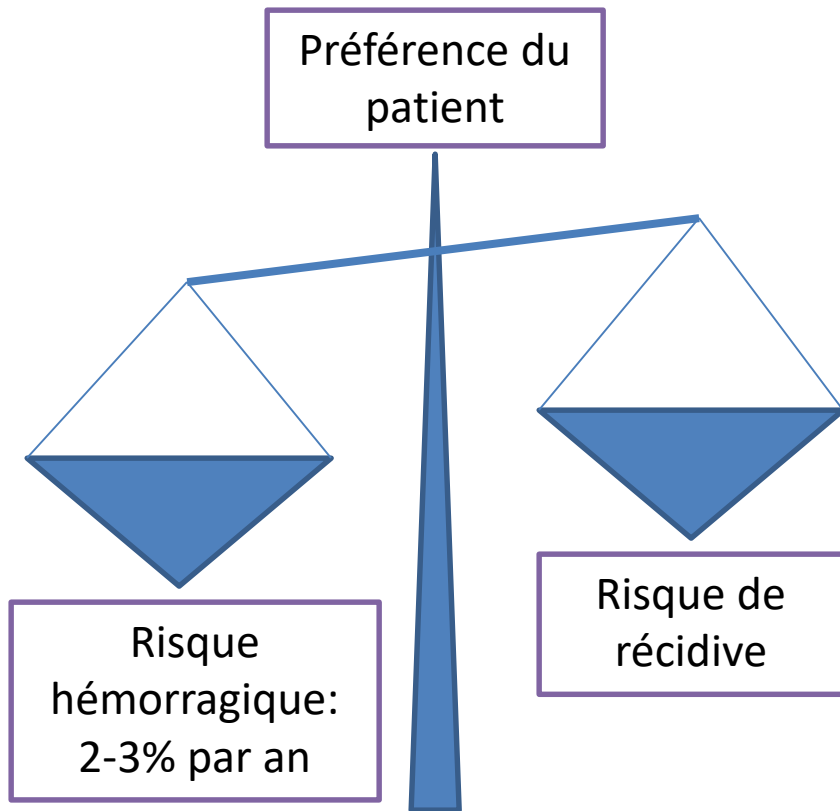
*Enoxaparine, nadroparine, daltéparine

Pas indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère
(clairance < 30 ml/minute)

Anticoagulants oraux directs: résumé

- Prophylaxie MTEV OK pour la traumatologie mais pas en médecine
- Traitement de la MTEV (TVP/EP) : OK
- CAVEAT: insuffisance rénale et potentielles interactions médicamenteuses.
- traitement aussi efficace que Sintron et Marcoumar avec probablement plus de stabilité de l'anticoagulation. Bonne stratégie thérapeutique dans la FA (sans remplacement valvulaire) et MTEV si pas d'insuffisance rénale ou interactions médicamenteuses.

Durée de la l'anticoagulation orale



Type d'événement	Risque de récidence	Durée de prophylaxie
1 ^{er} épisode, risque transitoire	≤ 3%/an	3 mois (EP:6mois)
1 ^{er} épisode, idiopathique	5-10%/an	≥ 3 mois (à long terme)
1 ^{er} épisode, cancer actif	5-10%/an	3-6 mois* (à long terme)
2 ^{ème} épisode	> 10%/an	à long terme

*Héparines à bas poids moléculaire préférables

Etat confusionnel chez une femme de 78 ans, hospitalisée pour une insuffisance rénale aiguë dans le contexte d'un cancer du sein métastatique. Son traitement à l'admission consiste en de la Prednisone® 20 mg/jour, de la morphine MST® 2x 30 mg/jour et des laxatifs. La patiente est agitée et désorientée dans le temps et dans l'espace. La patiente est afébrile et présente cliniquement des myoclonies aux 4 extrémités. Le diagnostic le plus probable à ce stade est :

-  1. Des métastases cérébrales
-  2. Un syndrome urémique
-  3. Une neurotoxicité aux opiacés
-  4. Une infection urinaire
-  5. Une psychose cortisonique

Etat confusionnel chez une femme de 78 ans, hospitalisée pour une insuffisance rénale aiguë dans le contexte d'un cancer du sein métastatique. Son traitement à l'admission consiste en de la Prednisone® 20 mg/jour, de la morphine MST® 2x 30 mg/jour et des laxatifs. La patiente est agitée et désorientée dans le temps et dans l'espace. La patiente est afébrile et présente cliniquement des myoclonies aux 4 extrémités. Le diagnostic le plus probable à ce stade est :

-  1. Des métastases cérébrales
-  2. Un syndrome urémique
-  3. **Une neurotoxicité aux opiacés**
-  4. Une infection urinaire
-  5. Une psychose cortisonique

Cette patiente de 74 ans est admise aux urgences pour une dyspnée sévère stade IV. A l'examen clinique, la tension artérielle est de 110/50 mmHg, la fréquence cardiaque à 120/min. Vous auscultez un souffle systolique éjectionnel au foyer d'Erb, aortique et carotidiens ddc. L'auscultation pulmonaire dévoile des râles diffus sur toutes les plages pulmonaires. La **stratégie diagnostique initiale peut inclure tous les éléments suivants sauf**

-  1.gazométrie
-  2.ECG
-  3. D-dimères
-  4.Radiographie thoracique
-  5. Pro-BNP

Cette patiente de 74 ans est admise aux urgences pour une dyspnée sévère stade IV. A l'examen clinique, la tension artérielle est de 110/50 mmHg, la fréquence cardiaque à 120/min. Vous auscultez un souffle systolique éjectionnel au foyer d'Erb, aortique et carotidiens ddc. L'auscultation pulmonaire dévoile des râles diffus sur toutes les plages pulmonaires. La **stratégie diagnostique initiale peut inclure tous les éléments suivants sauf**

-  1.gazométrie
-  2.ECG
-  3. D-dimères
-  4.Radiographie thoracique
-  5. Pro-BNP

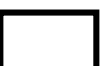
Ce patient alcoolique de 64 ans est admis depuis 4 jours aux soins intermédiaire pour la gestion d'une hémorragie digestive. Il développe depuis 10 heures des propos incohérents, une agitation psycho motrice importante. Vous pensez lui administrer quelques médicaments. Lesquels (ou lequel) est (sont) probablement requis dans l'urgence de cette situation:

-  **1.oxazepam**
-  **2.thiamine**
-  **3.phosphate**
-  **4.phenobarbital**
-  **5.acetylcystéine**

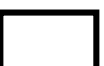
Ce patient alcoolique de 64 ans est admis depuis 4 jours aux soins intermédiaire pour la gestion d'une hémorragie digestive. Il développe depuis 10 heures des propos incohérents, une agitation psycho motrice importante. Vous pensez lui administrer quelques médicaments. Lesquels (ou lequel) est (sont) probablement requis dans l'urgence de cette situation:

-  1.oxazepam
-  2.thiamine
-  3.phosphate
-  4.phenobarbital
-  5.acetylcystéine

- Un homme de 74 ans est admis aux urgences dans le contexte d'une insuffisance rénale aigüe. Il est traité depuis des années pour un cancer prostatique et il est actuellement anurique depuis approximativement 48 heures. A son admission le patient a des nausées et des oedèmes marqués des membres inférieurs. La biologie d'entrée dévoile une créatinine à 1053 $\mu\text{mol/l}$, Na 128, K 5.5. l'ECG est considéré comme normal
- *Quelle est la prochaine étape dans la prise en charge de ce patient?*

-  1. administrer du glucose et de l'insuline i.v.
-  2. effectuer une gastroscopie
-  3. initier une hémodialyse
-  4. poser une sonde urinaire
-  5. administrer du sorbisterit per os et par lavement colique

- Un homme de 74 ans est admis aux urgences dans le contexte d'une insuffisance rénale aigüe. Il est traité depuis des années pour un cancer prostatique et il est actuellement anurique depuis approximativement 48 heures. A son admission le patient a des nausées et des oedèmes marqués des membres inférieurs. La biologie d'entrée dévoile une créatinine à 1053 $\mu\text{mol/l}$, Na 128, K 5.5. l'ECG est considéré comme normal
- *Quelle est la prochaine étape dans la prise en charge de ce patient?*

-  1. administrer du glucose et de l'insuline i.v.
-  2. effectuer une gastroscopie
-  3. initier une hémodialyse
-  4. **poser une sonde urinaire**
-  5. administrer du sorbisterit per os et par lavement colique

Une femme de 58 ans est traitée pour un choc septique d'origine pulmonaire. Son traitement a requis des antibiotiques(ceftriaxone-erythromycine), des amines et une intubation transitoire. Au troisième jour d'hospitalisation, l'état septique est contrôlé et la patiente extubée. L'équipe soignante vous informe que la patiente urine peu. TA 100/50 mmHg, FC:110/min. Ses valeurs de créatinine sont passées du premier jour de 88 $\mu\text{mol/l}$ à 220 $\mu\text{mol/l}$. Un spot urinaire dévoile un Na à 2, K 30. Le sédiment dévoile l'absence de leucos et les nitrites sont nég

Quelle est la prochaine étape dans la prise en charge de cette patiente?

- ☒ 1. administrer des doses croissantes de furosémide
- ☐ 2. changer les antibiotiques
- ☐ 3. initier une hémodialyse
- ☐ 4. reprendre le traitement d'amines (noradrénaline)
- ☐ 5. administrer du NaCl 0.9%

Une femme de 58 ans est traitée pour un choc septique d'origine pulmonaire. Son traitement a requis des antibiotiques(ceftriaxone-erythromycine), des amines et une intubation transitoire. Au troisième jour d'hospitalisation, l'état septique est contrôlé et la patiente extubée. L'équipe soignante vous informe que la patiente urine peu. TA 100/50 mmHg, FC:110/min. Ses valeurs de créatinine sont passées du premier jour de 88 $\mu\text{mol/l}$ à 220 $\mu\text{mol/l}$. Un spot urinaire dévoile un Na à 2, K 30. Le sédiment dévoile l'absence de leucos et les nitrites sont nég

Quelle est la prochaine étape dans la prise en charge de cette patiente?

-  1. administrer des doses croissantes de furosémide
-  2. changer les antibiotiques
-  3. initier une hémodialyse
-  4. reprendre le traitement d'amines (noradrénaline)
-  5. administrer du NaCl 0.9%

Homme de 45 ans hospitalisé pour un état confusionnel dans le contexte d'une cirrhose éthylique connue depuis 5 ans. A l'examen clinique, le patient est afébrile, TA à 96/60 mmHg, FC à 120/min, confus avec asterixis. Ascite importante et le reste de l'examen est non contributif.

Quel est l'examen paraclinique le moins utile à ce stade?

 **1.Examen du liquide d'ascite**

 **2.Mesure du taux d'ammonium sanguin**

 **3.Mesure de l'hémoglobine et hématocrite**

 **4.Mesure du TP/PTT**

 **5.Mesure de la créatinine, sodium et potassium**

Homme de 45 ans hospitalisé pour un état confusionnel dans le contexte d'une cirrhose éthylique connue depuis 5 ans. A l'examen clinique, le patient est afébrile, TA à 96/60 mmHg, FC à 120/min, confus avec asterixis. Ascite importante et le reste de l'examen est non contributif.

Quel est l'examen paraclinique le moins utile à ce stade?

☒ 1.Examen du liquide d'ascite

☒ 2.Mesure du taux d'ammonium sanguin

☒ 3.Mesure de l'hémoglobine et hématocrite

☒ 4.Mesure du TP/PTT

☐ 5.Mesure de la créatinine, sodium et potassium

Femme de 78 ans hospitalisée pour investigations de céphalées bi-temporales survenues depuis 48 heures avec des épisodes de perte visuelle transitoire de l'œil gauche. L'examen neurologique est normal et la patiente est afebrile. La biologie dévoile des thrombocytes à 600 T/l, discrète leucocytose à 10 G/L, anémie avec Hb à 105 gr/l, CRP à 5 et VS à 110 mm/heure. CT cérébral décrit comme normal.

Quel est la prochaine étape de prise en charge pour cette patiente?

☒ 1. Ponction lombaire

☐ 2. IRM cérébral

☐ 3. EEG

☐ 4. Initier une corticothérapie

☐ 5. Biopsie de l'artère temporale

Femme de 78 ans hospitalisée pour investigations de céphalées bi-temporales survenues depuis 48 heures avec des épisodes de perte visuelle transitoire de l'œil gauche. L'examen neurologique est normal et la patiente est afebrile. La biologie dévoile des thrombocytes à 600 T/l, discrète leucocytose à 10 G/L, anémie avec Hb à 105 gr/l, CRP à 5 et VS à 110 mm/heure. CT cérébral décrit comme normal.

Quel est la prochaine étape de prise en charge pour cette patiente?

☒ 1. Ponction lombaire

☐ 2. IRM cérébral

☐ 3. EEG

☒ 4. Initier une corticothérapie

☐ 5. Biopsie de l'artère temporale

Patient de 38 ans souffrant d'un SIDA traité depuis 6 ans. Hospitalisé pour baisse de l'état d'éveil, troubles visuels et état fébrile à 39 degrés sans frisson. Kernig négatif mais discrète raideur de nuque. Examen le plus utile à ce stade?

☒ 1. Ponction lombaire

☐ 2. EEG

☐ 3. CT-scan cérébral

☐ 4. IRM-cérébral

☐ 5. Fond d'œil par spécialiste

Patient de 38 ans souffrant d'un SIDA traité depuis 6 ans. Hospitalisé pour baisse de l'état d'éveil, troubles visuels et état fébrile à 39 degrés sans frisson. Kernig négatif mais discrète raideur de nuque. Examen le plus utile à ce stade?

☒ 1. Ponction lombaire

☐ 2. EEG

☐ 3. CT-scan cérébral

☐ 4. IRM-cérébral

☐ 5. Fond d'œil par spécialiste

Un diabétique de type 1 présente un coma hypoglycémique. Après injection im de glucagon il reprend conscience puis à nouveau comateux ?

- ☒ (A) Le glucagon n'est pas efficace dans le diabète de type 1
- ☐ (B) Contrôler la date d'expiration sur l'emballage
- ☐ (C) Injecter le glucagon im plus profondément
- ☐ (D) Donner des sucres par voie orale après l'injection
- ☐ (E) Il faut reconnaître les indications pour injection iv de G50%

Un diabétique de type 1 présente un coma hypoglycémique. Après injection im de glucagon il reprend conscience puis à nouveau comateux ?

- ☒ (A) Le glucagon n'est pas efficace dans le diabète de type 1
- ☐ (B) Contrôler la date d'expiration sur l'emballage
- ☐ (C) Injecter le glucagon im plus profondément
- ☒ (D) Donner des sucres par voie orale après l'injection
- ☐ (E) Il faut reconnaître les indications pour injection iv de G50%

♀ 23, rash prurigineux généralisé, dyspnée, restaurant (atd idem) FC 120', TA 85/50, FR 30', œd. périorbitaire, râles + expirium ↗

-  1) Monitoring 1 h, RAD
-  2) RAD avec prescr. CS pdt 1 sem
-  3) Hosp pour observation
-  4) RAD avec épinéph. + RDV allergo

♀ 23, rash prurigineux généralisé, dyspnée, restaurant (atd idem) FC 120/’, TA 85/50, FR 30/’, œd. périorbitaire, râles + expirium ↗

-  1) Monitoring 1 h, RAD
-  2) RAD avec prescr. CS pdt 1 sem
-  3) Hosp pour observation
-  4) RAD avec épinéph. + RDV allergo

Anaphylaxie

Clinique : 1 heure après expo : urticaire, angioedème, œdème laryngé, bronchospasme, hypotension, arrêt

**Choc anaphylactique dans 30% par ↗
perméabilité vasc. (↗ histamine et tryptase)**

Risque de réaction en phase tardive (6 à 12 h)

1) Epinéphrine

2) β -agonistes

3) O₂

4) liquide iv

5) Diphenhydramine 25 à 30 mg iv 4x/j,

6) Cimétidine 300 mg 2x/j

Homme de 69 ans hospitalisé pour une hémorragie digestive haute dans le contexte d'une cirrhose CHILD C d'origine éthylique. Gastroscope en urgence permet la ligature de plusieurs varices oesophagiennes. US abdominal dévoile une ascite importante et trois nodules hépatiques de 2 à 3 cm de diamètre suspect d'HCC. Au quatrième jour d'hospitalisation, récurrence d'hémorragie...

A ce stade, quelle procédure(s) n'est (sont) pas indiquée(s)?

- ☒ 1. Transfusions culots érythrocytaires et PFCs
- ☒ 2. Nouvelle gastroscopie
- ☒ 3. Considérer la mise en place d'un TIPS
- ☒ 4. Mise sur liste de transplantation hépatique en urgence
- ☐ 5. Administration de glypressine

Homme de 69 ans hospitalisé pour une hémorragie digestive haute dans le contexte d'une cirrhose CHILD C d'origine éthylique. Gastroscope en urgence permet la ligature de plusieurs varices oesophagiennes. US abdominal dévoile une ascite importante et trois nodules hépatiques de 2 à 3 cm de diamètre suspect d'HCC. Au quatrième jour d'hospitalisation, récurrence d'hémorragie...

A ce stade, quelle procédure(s) n'est (sont) pas indiquée(s)?

- ☒ 1. Transfusions culots érythrocytaires et PFCs
- ☒ 2. Nouvelle gastroscopie
- ☒ 3. Considérer la mise en place d'un TIPS
- ☒ 4. Mise sur liste de transplantation hépatique en urgence
- ☐ 5. Administration de glypressine

Dans le cadre d'un bilan d'une fatigue inhabituelle chez ce patient de 54 ans, vous recevez les valeurs suivantes de son bilan biologique : cortisol à 110 nmol/l au temps 0 (norme 200-520), cortisol à 190 nmol/l 60 min après injection de 250 µg de Synacthen (ACTH) (norme > 550). Le taux d'ACTH mesuré au temps 0 est à 8 ng/l (norme 10-60). La suite de la prise en charge va inclure une ou des propositions suivantes ?

- ☒ 1. Un CT scan abdominal
- ☒ 2. Une IRM hypophysaire
- ☒ 3. L'administration d'hydrocortisone
- ☒ 4. L'administration d'ACTH
- ☐ 5. L'administration de thyroxine.

Dans le cadre d'un bilan d'une fatigue inhabituelle chez ce patient de 54 ans, vous recevez les valeurs suivantes de son bilan biologique : cortisol à 110 nmol/l au temps 0 (norme 200-520), cortisol à 190 nmol/l 60 min après injection de 250 µg de Synacthen (ACTH) (norme > 550). Le taux d'ACTH mesuré au temps 0 est à 8 ng/l (norme 10-60). La suite de la prise en charge va inclure une ou des propositions suivantes ?

- ☒ 1. Un CT scan abdominal
- ☒ 2. Une IRM hypophysaire
- ☒ 3. L'administration d'hydrocortisone
- ☒ 4. L'administration d'ACTH
- ☐ 5. L'administration de thyroxine.

Vous êtes heureux d'avoir identifié une hypothyroïdie primaire chez cette femme de 38 ans qui présente une fatigue inhabituelle. Lequel ou lesquels de ces symptômes ou signes biologiques est-il/sont-ils compatible(s) avec votre diagnostic ?

☒ 1. Perte de cheveux

☒ 2. Dyslipidémie

☒ 3. Oligoménorrhée

☒ 4. Taux de créatine kinase (CK) élevé

☐ 5. Vitiligo

Vous êtes heureux d'avoir identifié une hypothyroïdie primaire chez cette femme de 38 ans qui présente une fatigue inhabituelle. Lequel ou lesquels de ces symptômes ou signes biologiques est-il/sont-ils compatible(s) avec votre diagnostic ?

☒ 1. Perte de cheveux

☒ 2. Dyslipidémie

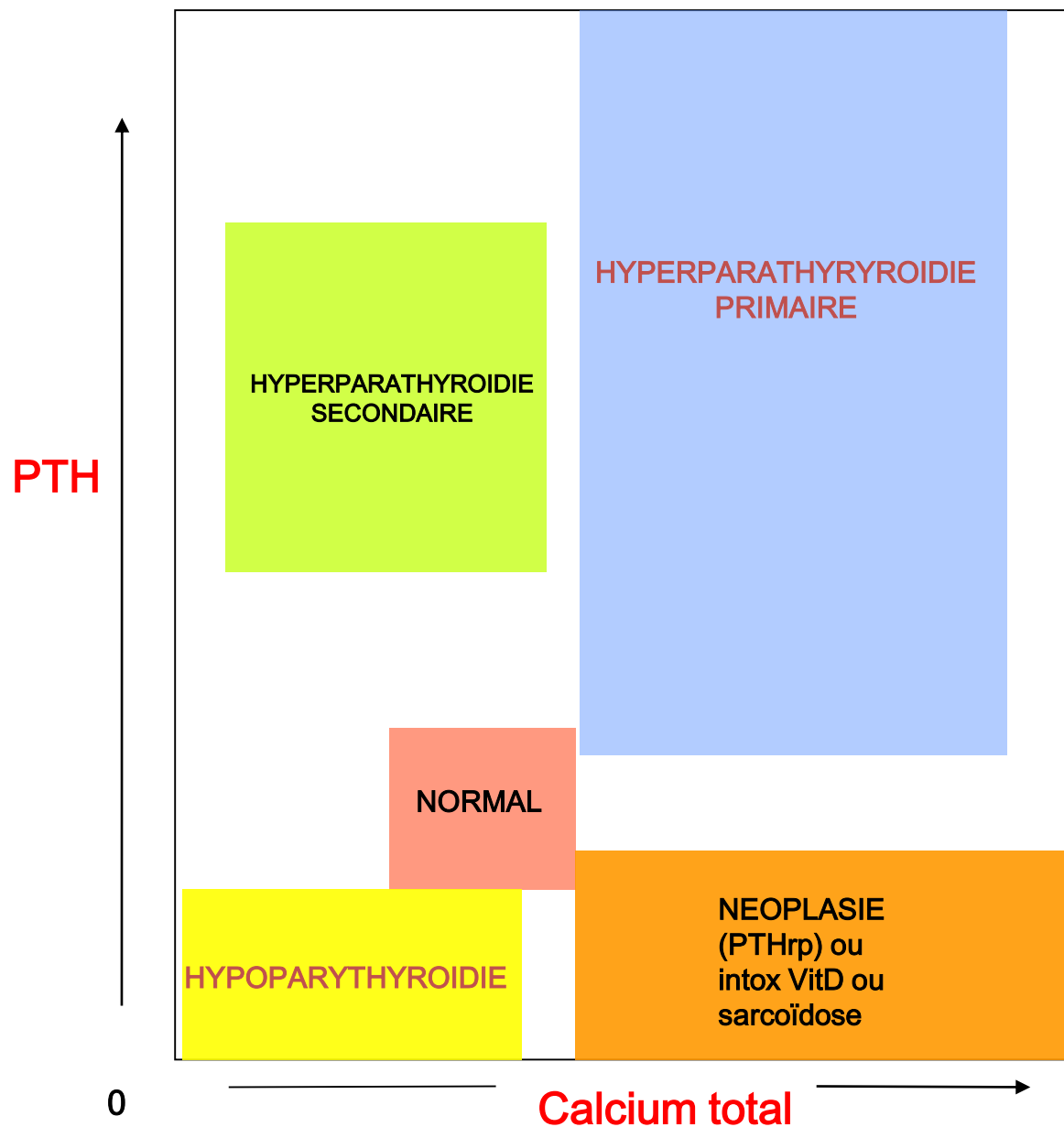
☒ 3. Oligoménorrhée

☒ 4. Taux de créatine kinase (CK) élevé

☐ 5. Vitiligo

Dans le cadre d'une investigation d'une fatigue chez cette patiente de 68 ans, vous recevez les valeurs biologiques suivantes. Calcium corrigé à 3.0 mmol/l (norme 2,1-2,5), phosphate à 1,7 mmol/l (norme 0,8-1,4), PTH à 9 ng/l (norme 10-70), 25-OH vitamine D à 15 µg/l (norme 8,8-42). Le(s) diagnostic(s) possible(s) à ce stade est/sont ?

- ☒ 1. Hyperparathyroïdie tertiaire
- ☒ 2. Sarcoïdose
- ☒ 3. Cancer du sein
- ☒ 4. Insuffisance rénale sévère
- ☐ 5. Atrophie villositaire du duodénum.



Dans le cadre d'une investigation d'une fatigue chez cette patiente de 68 ans, vous recevez les valeurs biologiques suivantes. Calcium corrigé à 3.0 mmol/l (norme 2,1-2,5), phosphate à 1,7 mmol/l (norme 0,8-1,4), PTH à 9 ng/l (norme 10-70), 25-OH vitamine D à 15 µg/l (norme 8,8-42). Le(s) diagnostic(s) possible(s) à ce stade est/sont ?

- ☒ 1. Hyperparathyroïdie tertiaire
- ☒ 2. **Sarcoïdose**
- ☒ 3. **Cancer du sein**
- ☐ 4. Insuffisance rénale sévère
- ☐ 5. Atrophie villositaire du duodénum.

Une patiente diabétique de 52 ans est traitée depuis 12 ans pour une hypertension artérielle par une trithérapie: lisinopril, métoprolol et amlodipine. Son traitement comprend également de la metformine, sitagliptine, aspirine cardio. A votre consultation les tensions artérielles sont comprises entre 155-170/90-98 mmHg.

Quelle est la prochaine étape dans la prise en charge de cette patiente?

-  1. ajouter un traitement diurétique
-  2. ajouter un traitement alpha bloqueur
-  3. proposer une recherche de sténose rénovasculaire par doppler
-  4. considérer une compliance médicamenteuse réduite

Une patiente diabétique de 52 ans est traitée depuis 12 ans pour une hypertension artérielle par une trithérapie: lisinopril, métoprolol et amlodipine. Son traitement comprend également de la metformine, sitagliptine, aspirine cardio. A votre consultation les tensions artérielles sont comprises entre 155-170/90-98 mmHg.

Quelle est la prochaine étape dans la prise en charge de cette patiente?

-  1. ajouter un traitement diurétique
-  2. ajouter un traitement alpha bloqueur
-  3. proposer une recherche de sténose rénovasculaire par doppler
-  4. considérer une compliance médicamenteuse réduite

Troisième hospitalisation en urgence pour cet homme de 68 ans pour des oedèmes pulmonaires à répétition associés à des mesures de tensions artérielles à 200-220/110-115 mmHg lors des hospitalisations. Il est habituellement traité par un bloqueur du SRA, diurétiques et amlodipine. La créatinine est à 160 $\mu\text{mol/l}$.

Le tableau clinique est compatible avec plusieurs diagnostics sauf:

-  1. phéochromocytome
-  2. compliance médicamenteuse altérée
-  3. sténose rénovasculaire
-  4. cardiopathie ischémique sévère
-  5. embolies pulmonaires

Troisième hospitalisation en urgence pour cet homme de 68 ans pour des oedèmes pulmonaires à répétition associés à des mesures de tensions artérielles à 200-220/110-115 mmHg lors des hospitalisations. Il est habituellement traité par un bloqueur du SRA, diurétiques et amlodipine. La créatinine est à 160 $\mu\text{mol/l}$.

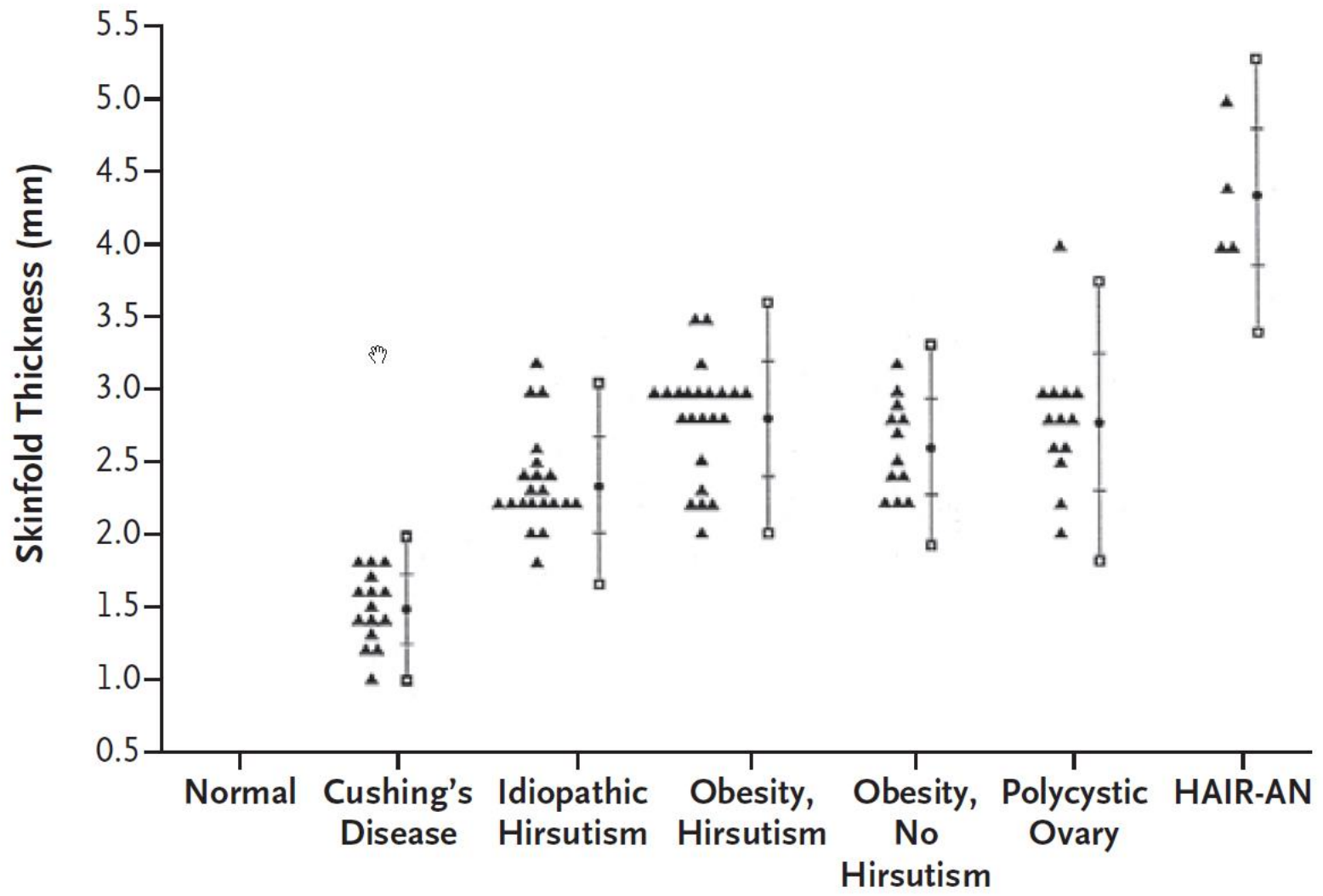
Le tableau clinique est compatible avec plusieurs diagnostics sauf:

-  1. phéochromocytome
-  2. compliance médicamenteuse altérée
-  3. sténose rénovasculaire
-  4. cardiopathie ischémique sévère
-  5. embolies pulmonaires

Investigations d'une prise pondérale de 25 Kg en 2 ans (IMC 36 kg/m²). Chute sur sa hauteur et fracture vertébrale L2. Difficulté à se lever d'une chaise. TA 160/95 mmHg. Diabète de type 2 nouveau. Vous évoquez en premier lieu:

- ☒ 1. Hypothyroïdie
- ☒ 2. Obésité exogène
- ☒ 3. Dépression
- ☒ 4. Cushing
- ☐ 5. Acromégalie





**Chance de détecter un Cushing sur la base d'une obésité:
1/500**

Si ostéoporose et obésité, likelihood augmenté 18

Si thin skin (< 2 mm) et obésité: positive likelihood 116

Si > 3 ecchymoses: positive likelihood 4

**Si patient obèse, thin skin, ostéoporose et ecchymoses:
95% de probabilité d'un Cushing !**

Investigations d'une prise pondérale de 25 Kg en 2 ans (IMC 36 kg/m²). Chute sur sa hauteur et fracture vertébrale L2. Difficulté à se lever d'une chaise. TA 160/95 mmHg. Diabète de type 2 nouveau. Vous évoquez en premier lieu:

- ☒ 1. Hypothyroïdie
- ☐ 2. Obésité exogène
- ☐ 3. Dépression
- ☒ 4. **Cushing**
- ☐ 5. Acromégalie

Une femme 89 ans, diabétique depuis 15 ans sous insuline, stop insuline dans le cadre d'une gastro-entérite.

**BMI 21; glycémie 28 mmol/L
stix: cétones**

-  (A) Diabète type 1
-  (B) Diabète type 2
-  (C) Diabète secondaire
-  (D) LADA

Une femme 89 ans, diabétique depuis 15 ans sous insuline, stop insuline dans le cadre d'une gastro-entérite.

**BMI 21; glycémie 28 mmol/L
stix: cétones**

-  (A) Diabète type 1
-  (B) Diabète type 2
-  (C) Diabète secondaire
-  (D) LADA

Types de diabète

- **Type 1** : destruction auto-immune des îlots pancréatiques, déficit sévère en insuline tendance à l'acidocétose
- **Type 2** : résistance à l'insuline et déficit relatif en insuline. Après 40 ans, obèse et AF + mais incidence en augmentation chez jeunes adultes et enfants
- **LADA (late autoimmune diabetes of adulthood)** : une minorité initialement diagnostiqués type 2, insulino-requérant avec glycémies labiles et autoanticorps destruction progressive des cellules bêta.
- **MODY (maturity onset diabetes of youth)** : hyperglycémie modérée, héréditaire, 3 générations
- **Secondaire** : Cushing, Acromégalie, médicamenteux (corticoïdes), maladie pancréatique
- **Diabète gestationnel** : 50% risque diabète type 2 à 5-10 ans